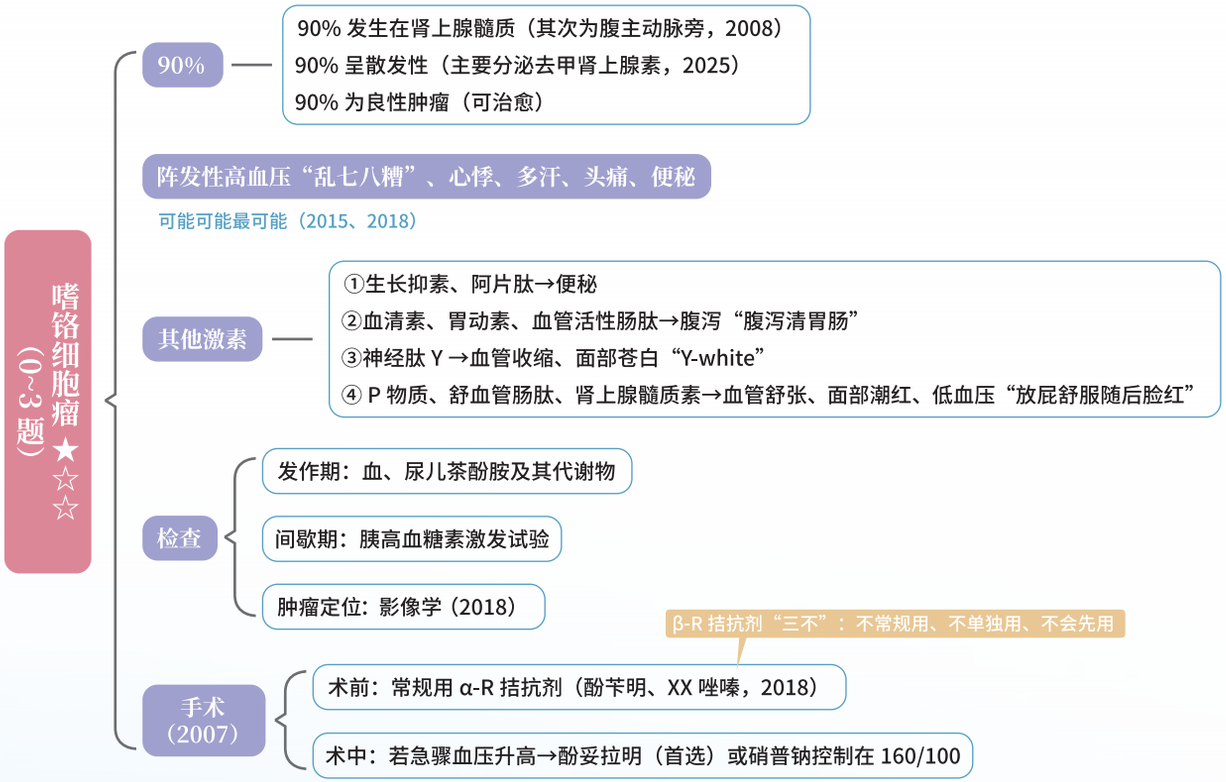

嗜铬细胞瘤★☆☆（0~3题）
90%
90% 发生在肾上腺髓质（其次为腹主动脉旁，2008）
90% 呈散发性（主要分泌去甲肾上腺素，2025）
90% 为良性肿瘤（可治愈）
阵发性高血压“乱七八糟”、心悸、多汗、头痛、便秘
可能可能最可能（2015、2018）
其他激素
①生长抑素、阿片肽→便秘
②血清素、胃动素、血管活性肠肽→腹泻“腹泻清胃肠”
③神经肽 Y →血管收缩、面部苍白“Y-white”
④ P 物质、舒血管肠肽、肾上腺髓质素→血管舒张、面部潮红、低血压“放屁舒服随后脸红”
检查
发作期：血、尿儿茶酚胺及其代谢物
间歇期：胰高血糖素激发试验
肿瘤定位：影像学（2018）
手术（2007）
β-R 拮抗剂“三不”：不常规用、不单独用、不会先用
术前：常规用 α-R 拮抗剂（酚苄明、XX 唑嗪，2018）
术中：若急骤血压升高→酚妥拉明（首选）或硝普钠控制在 160/100